

2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.07.09

항목	내용
회의	2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회
회의일	2026년 7월 8일
보고 대상	보험약가 · Market Access Leadership
공식 확인	건강보험심사평가원 「2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」
핵심 결과	림카토주 및 DCEP 병용요법은 급여기준 설정, 퍼제타주는 재논의로 공개

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 6차 암질심은 국산 CAR-T 림카토주와 재발성 · 불응성 다발골수종 DCEP 병용요법에 급여기준을 설정하고, 퍼제타주 조기 HER2 양성 유방암 수술 전 보조요법 확대는 재논의로 남겼다. MSD 직접 품목은 확인되지 않았지만, CAR-T · 다발골수종 · HER2 보조요법의 접근성 판단 기준은 MSD oncology 포트폴리오의 comparator, budget impact, 후속 급여기준 협상 논리에 영향을 준다.

3대 leadership implication

Implication	Leadership take-away
국산 CAR-T가 미설정 이후 급여기준 설정으로 전환됐다	림카토주는 이전 차수에서 급여기준 미설정이었다가 이번 차수에서 설정으로 공개됐다. ATMP · 고가 일회성 치료제는 보완자료, 환자 접근성, 위험분담 · 성과관리 논의가 결합될 때 재진입 가능성이 있음을 보여준다.
기존 regimen도 암질심 agenda의 핵심이다	DCEP 병용요법은 신약 품목이 아니지만 재발성 · 불응성 다발골수종에서 급여기준 설정을 받았다. 신약 중심 모니터링만으로는 암질심 결과를 충분히 설명하기 어렵고, 기존 병용요법의 기준 신설 · 확대도 별도 watchlist로 관리해야 한다.
보조요법 확대는 여전히 높은 증거 · 재정 기준을 요구한다	퍼제타주 수술 전 보조요법 확대가 재논의로 남은 것은 초기 치료 영역에서 환자군 규모, 치료기간, 장기 outcome, 기존 급여범위와의 중복성이 엄격히 검토되고 있음을 시사한다.

2. 공식 심의 결과: compact result table

중증(암)질환심의위원회 급여기준 심의결과

구분	품목/요법	성분	회사	대상 · 효능효과 요지	심의 결과
요양급여 결정신청	림카토주	안발캅타젠 오토류셀	큐로셀	두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 및 원발성 종격동 거대 B세포 림프종 성인 환자	급여기준 설정
급여기준 확대	DCEP 병용요법	덱사메타손+시클로포스파미드+에토포시드+시스플라틴	해당 없음	재발성 또는 불응성 다발골수종	급여기준 설정
급여기준 확대	퍼제타주	퍼투주맵	한국로슈	국소진행성 · 염증성 또는 초기 단계 HER2 양성 유방암 환자의 수술 전 보조요법으로 트라스투주맵 및 화학요법과 병용투여	재논의

3. 시장 · 정책 시사점

첫째, 림카토주의 급여기준 설정은 CAR-T · ATMP 접근성 논의의 기준선을 한 단계 구체화한다. 국산 CAR-T가 재논의 또는 미설정 상태에서 급여기준 설정으로 전환된 점은 고가 일회성 치료제에서도 임상적 필요, 대체치료 공백, 보완자료, 재정관리 장치가 결합될 경우 암질심 문턱을 넘을 수 있음을 보여준다. 이후 실제 등재 여부와 접근성은 약가협상, 위험분담 구조, 장기 추적 근거 관리 방식에서 결정될 가능성이 크다.

둘째, DCEP 병용요법 결과는 암질심 모니터링 범위를 신약 · 브랜드 품목에만 두면 안 된다는 신호다. 재발성 · 불응성 다발골수종에서 기존 성분 조합의 급여기준 설정은 실제 환자 접근성 변화가 개별 신약뿐 아니라 regimen 단위로도 발생함을 보여준다. 향후 혈액암 · 고형암 모두에서 기존요법 기준 신설, 병용요법 확대, line of therapy 조정이 별도 추적 대상이다.

셋째, 퍼제타주 재논의는 조기암 · 보조요법 확대의 높은 검토 강도를 재확인한다. 보조요법은 치료기간이 길고 대상 환자 수가 커질 수 있어 budget impact와 장기 outcome 불확실성이 동시에 중요해진다. HER2 양성 조기 유방암처럼 표준치료가 이미 복잡한 영역에서는 환자군 제한, 병용 조건, 재발위험 기준, 기존 급여범위와의 중복성을 더 정교하게 제시해야 한다.

넷째, 이번 차수는 직접 MSD 품목 부재에도 oncology access 기준선 변화를 읽어야 하는 이벤트다. CAR-T, 다발골수종, HER2 보조요법은 MSD 제품이 아니더라도 키트루다 및 MSD oncology 자산의 comparator 논리, treatment pathway 설명, patient funnel 산정, 장기 재정영향 관리에 간접 영향을 준다.

4. MSD 영향: direct issue는 없지만, read-through는 세 가지

4.1 CAR-T · ATMP: 고가 혁신치료제의 재진입과 관리조건 선례

림카토주 급여기준 설정은 고가 혁신치료제가 초기 미설정 이후에도 보완자료와 정책적 unmet need를 바탕으로 재진입할 수 있음을 보여준다. MSD 관점에서는 직접 CAR-T 품목 이슈는 아니지만, 고가 oncology 자산의 등재 논의에서 장기효과 불확실성, 환자군 제한, 성과관리, 위험분담 구조를 어떻게 설명할지에 대한 benchmark로 활용할 수 있다.

4.2 다발골수종 DCEP: regimen 단위 급여기준 관리 필요

DCEP 병용요법은 개별 브랜드 신약이 아니라 regimen 단위 결과다. 이는 oncology access landscape를 볼 때 제품명 중심 watchlist와 별도로 질환 · line · regimen 기준의 급여기준 변화가 필요함을 의미한다. MSD의 혈액암 · 면역항암 관련 전략에서도 실제 임상경로 변화가 어떤 기존요법 기준 변경에서 발생하는지 추적해야 한다.

4.3 퍼제타주: 보조요법 budget impact와 장기 outcome 기준 재확인

퍼제타주 재논의는 보조요법 확대에서 임상적 필요만으로 충분하지 않고, 장기 outcome, 환자군 규모, 치료기간, 기존요법 대비 incremental benefit이 함께 검토된다는 점을 재확인한다. MSD oncology 적응증 확대 준비에서도 adjuvant · perioperative 영역은 patient funnel, biomarker/위험군 제한, duration assumption, 재발 억제 근거를 leadership 단계에서 선제 점검해야 한다.

5. Next watchlist

후보	현재 의미	MSD 관찰 포인트
퍼제타주	이번 차수 재논의 결정으로 보완 후 재상정 가능성 존재	HER2 조기 유방암 보조요법의 장기 outcome · BIA 논리, 환자군 제한 방식 확인
림카토주	급여기준 설정 후 후속 절차 진입 예상	약가협상 개시, 위험분담 또는 성과관리 조건, 실제 등재 시점

후보	현재 의미	MSD 관찰 포인트
DCEP 병용요법	다발골수종 기존 regimen 급여기준 설정	혈액암 치료경로 내 기존요법 접근성 변화와 후속 신약 comparator 영향 확인
임텔트라	소세포폐암 unmet need 및 환자 접근성 이슈 지속	실제 재신청 · 안전화 신호, 급여기준 설정 가능성, 후속 약평위 전환 여부
티루캡 등 유방암 정밀치료제	HR+/HER2- 및 biomarker 기반 유방암 접근성 공백 지속	국내 신청 상태, 보완 근거, 조기 · 전이성 구분과 BIA logic 확인

6. Leadership actions

1. 후속 고시 · 세부기준 확인: 림카토주와 DCEP는 암질심 문구만으로 실제 적용 범위와 시행시점을 확정하지 말고, 후속 고시 · 약가협상 · 급여기준 세부 공고를 확인한다.
2. Regimen watchlist 분리: 신약 품목 watchlist와 별도로 기존 병용요법 · regimen 단위 급여기준 신설/확대 항목을 관리한다.
3. 보조요법 BIA template 점검: 퍼제타주 재논의 사례를 반영해 조기암 · 보조요법 자료 준비 시 eligible population, 치료기간, 장기 outcome, 중단 기준을 분리해 검토한다.
4. 차기 암질심 · 약평위 연결 추적: 암질심에서 급여기준 설정된 항목은 약평위 · NHIS 협상 · 고시까지 연결 추적하고, 재논의 항목은 보완자료 제출 및 재상정 신호를 월간 watchlist에 유지한다.

7. 출처 및 해석 범위

본 brief의 공식 사실은 건강보험심사평가원이 공개한 「2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」의 품목명, 성분 · 요법, 회사명, 대상 질환 · 급여기준 신청 내용, 심의 결과 문구에 근거한다. 시장 · 정책 시사점과 MSD 영향은 해당 공식 결과를 바탕으로 한 Market Access 해석이며, 실제 등재 여부 · 약가 · 시행일은 약가협상, 건강보험정책심의위원회, 보건복지부 고시 이후 확정된다.

이 문서는 공개 결과를 leadership 의사결정용으로 압축한 것이며, 비공개 환급률, 회사별 내부가격, 최종 약가 또는 특정 품목의 등재일을 추정하지 않는다. 따라서 후속 업무는 공식 고시와 세부급여기준 확인, 환자군 산정 가점 업데이트, 가격수용 · 위험분담 여부 확인으로 분리해 진행한다.